



1

55. ÅRGANG | 01 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Angst

PPT nr. 1-2018

Hjælp til Selvhjælp

– et forældrebaseret kognitivt adfærdsterapeutisk
selvhjælpsprogram

*Af Bianca Munkebo Christiansen, Barbara Hoff Esbjørn
& Sonja Breinholst*

Hjælp til Selvhjælp

– et forældrebaseret kognitivt adfærdsterapeutisk selvhjælpsprogram



Denne artikel præsenterer et pilotstudie fra Center for Angst, hvor et nyt selvhjælpsprogram, Hjælp til Selvhjælp, målrettet forældre til børn med moderate niveauer af angst, afprøves. Artiklen vil give indblik i effekten af eksisterende internationale forældrebaserede behandlinger og selvhjælpsprogrammer med fokus på nogle af de udfordringer, der opstår, når terapeutens tid minimeres i behandlingen af børn og unges angst. Hjælp til Selvhjælp programmet vil blive præsenteret som et alternativ til de eksisterende lav-intensive og ressourcebesparende interventioner, idet denne er designet til at være kompatibel med en hverdagssetting i PPR. Formålet med Hjælp til Selvhjælp og nærværende artikel er at udbrede viden om effektive, ressourcebesparende behandlinger til angste børn landet over.

*Af Bianca Munkebo Christiansen, cand.psych., videnskabelig assistent,
Center for Angst, Københavns Universitet
Barbara Hoff Esbjørn, professor mso, leder af Center for Angst,
Københavns Universitet
& Sonja Breinholst, cand.psych. aut., ph.d., post doc.,
Center for Angst, Københavns Universitet*

Flere og flere forældre oplever, at deres barn lider af angst. De oplever, at angsten forstyrrer deres barns hverdag og gør det svært for familien i sin helhed at fungere. Det har ført til en øget efterspørgsel efter gode behandlingstilbud, som kan sikre, at barnet overvin-der angsten. Men hvor mange børn er der egentligt tale om? Angstlidelser er en af de mest hyppigt forekomne psykiatriske lidelser både i barn- og ungdommen. Forskning i forekomster af psykiatriske angstlidelser har vist, at helt op til 23 % af alle unge, når de fylder 26 år, vil have opfyldt kriterierne for minimum én angstlidelse (Cope-land, Angold, Shanahan & Costello,

2014). Selvom der identificeres flere børn med angstlidelser i dag end tidli-gere, er forekomsterne af angstdiagno-ser i Danmark ikke anderledes end i udlandet. Dette tyder på, at børn med angst i Danmark tidligere blot har væ-ret overset, snarere end at der er tale om en reel stigning. Hvorvidt børnenes rapportering af angstsymptomer også er steget, så dette niveau også nu når op på det, man ser internationalt, ved vi endnu ikke. En sådan stigning kun-ne også handle om, at det at have en angstlidelse i højere grad anerkendes som noget man kan få hjælp til, og ikke noget man 'bare' må leve med. Ubehandlet angst viser sig som en risi-

kofaktor for skolevægring, skolefaglige vanskeligheder, social isolation og mobning i barn- og ungdommen samt en øget risiko for misbrug, angst og depression i voksenlivet (Moffitt et al., 2007; Reijntjes, Kamphuis, Prinzie & Telch, 2010). Angst forstyrrer ikke kun det ramte individ. Sundhedsstyrelsens rapport (2015) viste, at angst hvert år er skyld i tabt produktion for mere end 8,6 mia. kroner samt er den hyppigste årsag til førtidspension blandt psykiske og psykiatriske lidelser.

I Center for Angst (CfA) ved Københavns Universitet har vi bemærket et paradoks i det danske samfund. På trods af de identificerede negative langtidskonsekvenser for individet såvel som for det danske samfund, er der på nuværende tidspunkt stor variation i hvor meget og hvilken type behandling, der tilbydes på tværs af de danske kommuners PPR og familierådgivninger. I flere kommuner har psykologerne et begrænset antal sessioner til rådighed pr. barn, hvilket vanskeliggør udførelse af nødvendig behandling. Dette faktum samt at der i Danmark ikke eksisterer et fast kommunalt eller statsligt tilbud til angste børn, medfører, at familier ofte må betale selv i privatregi for at få deres børn behandlet for angst. Flere forældre har beskrevet, at det er en jungle at identificere, hvilken form for hjælp, der skal vælges. Hvad er "det rigtige"? Og hvordan sikrer forældrene sig, at den ydelse, de vælger, er det, der efter al sandsynlighed vil virke bedst?

Hvis vi vender os mod den internationale forskning, har kognitiv adfærdsterapi vist sig at være den terapiform, der – i øjeblikket – er den bedst under-

søgte og mest lovende behandling til angstlidelser. Den seneste store meta-analyse på området er fra 2015. I studiet samlede man alle randomiserede kontrollerede studier, der sammenlignede kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af angstlidelser i barn- og ungdommen med enten 1) venteliste-kontrol, 2) en aktiv kontrol som dækker over en psykologisk placebo typisk i form af psykoedukation eller biblioterapi, eller 3) anden typisk givet behandling (*treatment as usual*). Metaanalysen konkluderer, at kognitiv adfærdsterapi på nuværende tidspunkt er signifikant mere virksomt med 58,9 % børn og unge fri for alle angstlidelser efter endt behandling (James, James, Cowdrey, Soler & Choke, 2015). Det er dog alment anerkendt at behandlingseffekten afhænger af, hvor behandlingen gives. Typisk ser man en bedre behandlingseffekt i universitetsklinikker der er specialiserede i at behandle angstlidelser, sammenlignet med behandling i hverdagspraksis (Ischikawa, Okajima, Matsuoka & Sakano, 2007). Dette er et problem, da størsteparten af børnene befinder sig i primærsektoren. CfA har derfor interesseret sig for, hvordan vi kan sikre, at den samme kvalitet i behandling som ses ved universitetsklinikker bliver offentligt tilgængeligt for forældre til angste børn og unge i hverdagens praksis.

Behandlingseffekter af forældrebaserede behandlinger og selvhjælpsprogrammer

En måde at forsøge at få behandling ud til flere børn, har været ved at lade forældrene behandle deres børn. En

metaanalyse fra 2014 har vist, at behandlinger, der aktivt overdrager behandlingskontrol til forældrene gennem *“transfer of control”*, sådan at forældrene lærer at træne modig adfærd og eksponere med deres barn, er signifikant mere effektiv et år efter endt behandling sammenlignet med behandling uden dette fokus (Manassis et al., 2014). Denne effekt kan skyldes, at forældrene har lært at vedligeholde den positive udvikling efter behandlingens afslutning og har erfaret, at de som forældre kan mestre barnets angst.

Ikke desto mindre, er der til stadighed ganske få studier, der undersøger effekten af angstbehandling, der foregår via forældrene. Denne type behandling kan opdeles i to typer: 1) terapeutleveret angstbehandling via forældrene og 2) selvhjælpsprogrammer til forældre. I henhold til den førstnævnte type, er der på nuværende tidspunkt to randomiserede, kontrollerede studier (Cartwright-Hatton et al., 2011; Creswell et al., 2017) og én open trial (Lebowitz, Omer, Hermes & Scahill, 2014), hvor der gives en terapeutleveret angstbehandling igennem forældrene. Cartwright-Hatton og kolleger (2011) undersøgte det manualbaserede program: ‘Timid to Tiger’ i et randomiseret, kontrolleret studie med venteliste-kontrol. Dette er en 10 sessions gruppebaseret kognitiv adfærdsterapeutisk intervention til forældre. Forældrene, der blev inkluderet i nærværende studie, havde børn i alderen mellem 2,7 og 9 år. Af de børn, hvis forældre havde gennemgået Timid to Tiger programmet, var 32 % frie af alle angstlidelser, og 57 % var fri af deres

primære angstlidelse efter endt behandling. For børn, hvis forældre var i venteliste-kontrol gruppen var kun 6% fri for alle angstlidelser og 15 % fri for deres primære angstlidelse efter endt venteperiode. Forskellen mellem de to grupper var signifikant, om end effekten af programmet Timid to Tiger var mindre, end den, der generelt ses ved de terapeutleverede kognitiv adfærdsterapeutiske programmer (James, James, Cowdrey, Soler & Choke, 2015). Videre har Lebowitz og kolleger (2014) undersøgt et manualbaseret program ved navn SPACE. Det består, ligesom Timid to Tiger, af, at forældrene modtager 10 sessioner kognitiv adfærdsterapi målrettet forældres adfærd i forhold til barnets angst. Forældre, hvis børn opfyldte kriterier for minimum én angstlidelse og ikke var motiveret for, eller havde nægtet individuel behandling, blev inkluderet i studiet. Resultaterne viste, at 60 % af børnene oplevede et signifikant fald i angstsymptomer fra før til efter behandling målt på selvrapporterede spørgeskemaer (Lebowitz, Omer, Hermes & Scahill, 2014). Studiet har dog to væsentlige metodemæssige fejkilder: 1) der måles kun på forekomsten af angstsymptomer og ikke på antallet af diagnoser efter endt behandling, samt 2) manglen på kontrolgruppe. Disse fejkilder gør det svært at konkludere endeligt på effekten af programmet og sammenholde det med de generelle effekter af terapeutleveret kognitiv adfærdsterapi (James, James, Cowdrey, Soler & Choke, 2015). Studiets resultater tyder dog på, at en intervention til børn med angst gennem deres forældre kan være effektivt – også selvom børnene, ifølge

deres forældre, har nægtet eller udvist lav motivation for individuel behandling med en terapeut. Selvom både *Timid to Tiger* (Cartwright-Hatton et al., 2011) og *SPACE* programmerne (Lebowitz, Omer, Hermes & Scahill, 2014) er forældrebaseret, og terapeuten derfor ikke behandler barnet direkte, er disse behandlinger næsten ligeså tids- og ressourcekrævende som traditionel terapeutleveret kognitiv adfærdsterapi til børn, fordi terapeuten behandler barnet igennem forældrene. Den enkelte terapeut bruger derfor ikke mindre tid og ressourcer, selvom der arbejdes gennem forældrene.

Der er dog et stigende behov for at kunne tilbyde lavintensive ressourcebesparende behandlinger i hverdagens praksis, hvorfor den internationale forskning har haft et fokus på at reducere den nødvendige tid, terapeuten er involveret i behandlingen, uden at miste effekt. Creswell og kolleger (2017) har derfor undersøgt og sammenlignet effekterne af to kortvarige psykologiske behandlinger: et forældrebaseret kognitivt terapeutisk forløb og et alment anvendt løsningsfokuseret forløb med både barn og forældre. Begge forløb havde 5 timers terapeut kontakt. Begge forløb viste sig at være effektive i at reducere angstsymptomer. I det kognitive forløb havde 59 % af børnene signifikant færre angstsymptomer efter behandling sammenlignet med 69 % i det løsningsfokuserede forløb. Som i Lebowitz og kollegers studie (2014) rapporterer studiet ikke på forekomsten af diagnoser hos børnene, men kun om et generelt fald i angstsymptomer. Der blev dog fundet en forskel i forhold til omkostningerne forbundet

med de to behandlinger. Det forældrebaseret, kognitivt adfærdsterapeutiske havde signifikant lavere udgifter i forhold til terapeutens ressourcer (eks. tid til kørsel, logistik og koordination af terapi med forældre og/eller barn) samt samfundsmæssige udgifter (forældre og barns tid fra arbejde/skole) end den løsningsfokuseret intervention. Disse studier er et afgørende skridt i undersøgelsen af behandlingseffekten, når terapeutens tid per familie mindskes. Der eksisterer dog ligeledes studier, der undersøger behandlinger, hvor terapeutens tid med familierne nedsættes til et absolut minimum. Dette leder os derfor videre til en gennemgang af den anden type af forældrebaserede angstbehandlinger: de internetbaserede interventioner og selvhjælpsprogrammerne med minimal terapeutkontakt.

Som en naturlig følge af børn og unges kundskaber med teknologi samt en stigende interesse i selvhjælpsinterventioner, er internetbaserede interventioner langsomt begyndt at vinde ind på markedet. En af de mest velafprøvede, internetbaserede interventioner rettet mod børn og unge med angstlidelser uden terapeutkontakt er *BRAVE* online programmet. Dog viser den umiddelbare effekt efter endt behandling af denne internetbaserede intervention, at kun 26,6 % af deltagerne er fri for alle deres angstlidelser (Spence et al., 2011). Dermed er effekten noget lavere end de generelle effekter for terapeutleveret kognitiv adfærdsterapi. Når vi ser på forældrebaseret selvhjælpsintervention, der er målrettet børn med angst, er Lyneham & Rapees studie fra 2006 det hidtil

eneste afprøvede – udover CfA's nyudviklede selvhjælpsprogram. I det australske studie blev deltagerne fordelt mellem tre grupper med forskellige grader af terapeutkontakt: I en gruppe modtog forældrene ni planlagte telefonopringninger fra terapeuten, i den anden gruppe var der ni planlagte e-mails fra terapeuten og i den sidste gruppe lå initiativet til kontakt med en terapeut hos forældrene alene. Lyneham & Rapee (2006) konkluderede, at gruppen med telefonkontakt havde størst effekt efter endt behandling. I alt 79 % af børnene var fri for alle deres angstlidelser i denne gruppe. Til sammenligning var kun hhv. 33 % og 31 % af børnene i gruppen, der modtog e-mails, og hvor forældrene selv skulle tage initiativ til kontakt, fri for alle deres angstlidelser. Dette studie understøtter altså, at et selvhjælpsprogram med nogen fastlagt terapeutkontakt kan være virksomt.

Når vi ser samlet på både de internationale forældrebaserede interventioner og selvhjælpsprogrammer, er der nogen evidens for, at disse interventioner kan hjælpe børn ud af angsten, om end effekten bliver noget lavere, når terapeutkontakten er markant reduceret. Der er dog fortsat behov for flere studier, der undersøger dette for en endelig konklusion. På baggrund af den eksisterende internationale forskning på området og i takt med den stigende efterspørgsmål på effektive og ressourcibesparende behandlinger til børn med angst i kommunerne og regionerne, udviklede Center for Angst *Hjælp til Selvhjælp*, et selvhjælpsprogram, der kunne optimere effekten af be-

handlingen og samtidigt bibeholde et lavt ressourceforbrug.

Hjælp til Selvhjælp

Hjælp til Selvhjælp er et lav-intensivt gruppebaseret selvhjælpsprogram til forældre. Programmet baserer sig på kognitive adfærdsterapeutiske principper og idéen om *transfer of control*, hvor terapeuten overdrager behandlingskontrollen til forældrene, så de lærer barnet modig adfærd og eksponeringsprincipper. Hjælp til Selvhjælp kan ses som en opkvalificering af forældrenes kompetencer til at behandle deres børns angstlidelser og sætte barnet ind på rette udviklingskurs igen. Programmet er målrettet forældre, som har et barn med moderate niveauer af angst. Hertil kan man spørge: Hvad betyder, og hvordan defineres et moderat niveau af angst? Diagnostisk opererer man med grader af funktionsforstyrrelse; altså i hvor høj grad barnets hverdag forstyrres af angsten. Funktionsforstyrrelsen kan vurderes ud fra fire områder af barnets liv: 1) barnets mulighed for at gå i skole, 2) familieliv og -struktur 3) relationer med venner, samt 4) om barnet kan gøre det, som det har lyst til at gøre. Moderate niveauer af angst vurderes typisk til at forstyrre 2-3 ud af 4 områder i nogen grad, hvor svære niveauer af angst i høj grad forstyrrer 3-4 områder af barnets liv. Typisk vil det sige at barnet har 1-2 angstlidelser, men ikke flere. Til sammenligning opfylder de børn Center for Angst behandler typisk diagnostiske kriterier for 3-4 angstlidelser. I Center for Angst oplever vi, at det typisk er, når angsten forstyrrer i

høj grad og dermed bliver af en høj funktionsforstyrrelse, at forældrene søger professionel behandling til deres børn. Hjælp til Selvhjælp er derfor designet til at kunne inkludere forældre til børn med moderate niveauer eller som forebyggelse, inden angsten får alvorligt fat.

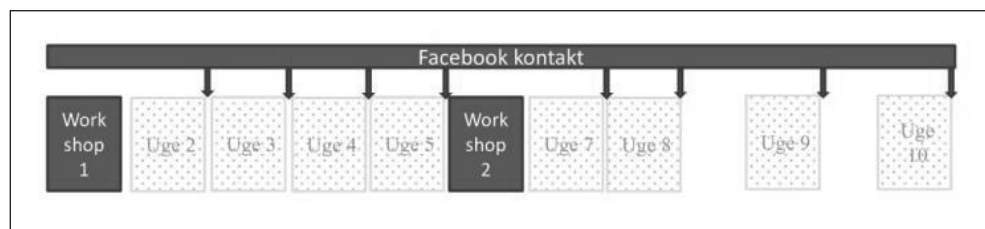
Programmet er manualbaseret og forløber over 12 uger, hvor *forældrene* arbejder med barnet. Hjælp til Selvhjælp manualerne (Christiansen & Esbjørn, unpublished manuscript) er en tilpasset selvhjælpsversion af Cool Kids børne- og forældremanualerne (Rapee et al., 2006). Udover udleveringen af Hjælp til Selvhjælp manualerne, skal forældrene deltage i 2 x 2 timers forældreworkshop med maksimalt otte forældrepar i hver gruppe. De to workshops ledes af to psykologer. Forældrene inviteres desuden til at blive medlem af en hemmelig Facebook gruppe, hvor de indbyrdes kan dele erfaringer fra programmet med hinanden. Behandlingen initieres med 1. forældreworkshop, som markerer uge 1 af behandlingen. Her får forældrene udleveret Hjælp til Selvhjælp manualerne (Christiansen & Esbjørn, unpublished manuscript), såfremt de ikke har fået disse tilsendt før forældreworkshoppen, samt online adgang til en hemmelig Facebook gruppe.

Den anden forældreworkshop foreligger seks uger inde i Hjælp til Selvhjælp programmet og markerer 6. uge af behandlingen. **Figur 1** neden for illustrerer Hjælp til Selvhjælps behandlingsforløb.

Der er indlagt to uger mellem session 8-9 og session 9-10 for at give familierne ekstra tid og mulighed for at øve modig adfærd og udføre eksponering i hjemmet. Figur 1 giver endvidere læseren et overblik over terapeutens ressourceforbrug; de to forældrewshops samt at opslå statusopdateringer i Facebook-grupperne, der opfordrer forældrene til hhv. at afslutte ugens session, påbegynde den næste samt dele erfaringer med hinanden. Den anvendte therapeuttid per familie er estimeret til 1,25 time i Hjælp til Selvhjælp, når terapeuten er trænet i at udføre programmet.

Indholdet i forældrewshops

Den første forældreworkshop har til formål at etablere et sammenhold mellem forældrene, som oplever samme typer vanskeligheder med deres børn. Forældrene får mulighed for at dele, hvordan angsten påvirker familiens hverdag. Terapeuterne har til opgave at hjælpe forældrene med at identificere mål for behandlingen ogpsykoedukere forældrene om de mekanismer,



Figur 1. *Hjælp til Selvhjælp* behandlingsforløb og -struktur.

som, forskningen har vist, vedligeholder angst. I denne psykoedukation er der særligt fokus på, hvordan barnets angst kan udløse uhensigtsmæssig forældreadfærd, som i et bidirektionelt forhold vedligeholder barnets angst (for yderligere information om forældreadfærd, se Thastums artikel i samme nummer). Når terapeuterne har rundet målsætning og psykoedukation om vedligeholdende mekanismer, introduceres forældrene til de generelle kognitive adfærdsterapeutiske principper samt de specifikke redskaber, der introduceres i selvhjælpsmanualerne til og med 5. session. Forældrene opkvalificeres derved til at kunne anvende og udføre teknikkerne selvstændigt i hjemmet med deres børn. Endeligt præsenteres forældrene i første forældreworkshop for Facebook gruppens formål og anvendelse samt hvad de kan forvente som led i deltagelsen i Hjælp til Selvhjælp.

Et tema, som terapeuterne skal være særligt opmærksomme på ved første forældreworkshop er etableringen af forældrenes tro på deres egen mestring, også kaldet self-efficacy beliefs. Forældrene skal styrkes i deres tro på, at de kan mestre teknikkerne og håndtere at hjælpe deres barn ud af angsten, når de forlader workshopen og skal hjem og i gang med programmet. Dermed sætter den første forældreworkshop også scenen for overdragelsen af kontrol fra terapeuterne til forældrene. I CfA plejer vi altid at fortælle forældrene: "Hvis I vidste, hvad vi ved om angst i barndommen, vil det være meget nemmere for jer at være forældre til et angst barn. Det er det, vi vil videregive til jer i Hjælp til Selv-

hjælp". Terapeutens vigtigste opgave er derfor at sikre tilstrækkelig tro på egen mestring hos forældrene, til at de kan holde motivationen og troen på succes indtil næste workshop midt i programmet. Fokus bliver fra terapeutens side at lytte efter opgivenhed, usikkerhed i forældrerollen og urealistiske forestillinger om barnets mulige reaktioner. Terapeuten skal korrigere disse opfattelser, gerne med henvisninger til andre situationer, hvor forældrene har mestret og formået at få børnene til at gøre det, de beder om – også selvom børnene umiddelbart ikke vil.

Anden workshop midt i programmet skal sikre fortsat fremgang samt fange og korrigere faldgruber og misforståelser. Denne workshop er designet til at give plads til forældrenes frustrationer samt korrigere og finpudse forældrenes udførelse af teknikkerne. Indledningsvist identificerer terapeuten først faldgruberne, som de fleste forældre på et tidspunkt i udførelsen af sådan et behandlingsprogram vil være endt i. Derefter drøftes og korrigeres vedligeholdende adfærd fra både barnets og forældrenes side. I forbindelse hermed er det oplagt videre at identificere og justere eventuelle uhensigtsmæssige eksponeringshierarkier. Anden workshop ligger umiddelbart i forlængelse af den uge, hvor forældrene i samspil med barnet har skullet opbygge eksponeringshierarkier og er påbegyndt at arbejde med "trappestiger" for at øve modig adfærd (for yderligere information om behandlingsteknikkerne, se Breinholst, Christiansen & Esbjørns artikel i samme nummer). Derfor skal terapeuten også opsummere fra første forældreworkshop og psykoedukere ge-

nerelt om konstruktionen af ekspone-
ringshierarkier. Terapeutens sidste op-
gave i anden workshop er at gennemgå
de sidste redskaber i selvhjælpsmanu-
alerne samt at samle op på brugen af
Facebook gruppen. Ved behov kan te-
rapeuten minde forældrene om forde-
len ved at drøfte udfordringer og suc-
cesser med hinanden i online forum-
met.

Flere terapeutiske opgaver er fælles
for de to workshops. Terapeuterne skal
kontinuerligt være opmærksomme på
forældrenes tro på egen mestring og
søge at øge disse antagelser. Derudover
er det tilmed yderst vigtigt, at terapeu-
terne har et stærkt og indgående kend-
skab både til angstlidelser i barn- og
ungdommen, men også til kognitiv ad-
færdsterapi generelt. Det er en udbredt
misforståelse, at alle psykologer og te-
rapeuter kan køre et Cool Kids forløb.
Slår man op på side 1 i Cool Kids ma-
nualen, står der, at terapeuterne skal
have specialiseret viden om angst hos
børn samt modtaget efteruddannelse i
kognitiv adfærdsterapi, for at kunne
gennemføre programmerne korrekt.
Det samme er gældende for Hjælp til
Selvhjælp, såfremt der skal opnås gode
effekter. Terapeuterne skal være så
sikre i deres kognitive metode, at de
kan undervise forældre samt besvare
metodiske spørgsmål og forsvare ratio-
nalet for at arbejde på denne måde.
Dette er nødvendigt for at øge foræl-
drenes compliance med behandlingen.
Specialiseret viden om angst hos børn
og kognitiv adfærdsterapi kan endvide-
re sikre, at man, som terapeut, kan
formidle budskaber utvetydigt og uden
tvivl, så terapeuten kan agere rollemo-
del for forældrene. Dette er nødven-

digt, fordi det ikke er nok, at forældre-
ne modtager *viden* om, hvordan man
gør. De har også behov for at *observere*
det – og ikke mindst mærker den sik-
kerhed, vi, som terapeuter, tager med
os ind i rummet, så de kan kopiere det.
Dette kræver terapeutisk træning og
løbende kvalificeret supervision for, at
man kan føle sig sikker i denne rolle
som terapeut.

Pilotstudie: Hjælp til Selvhjælp i Center for Angst

I det følgende præsenteres vores meto-
de, procedure, karakteristik af delta-
gergruppen samt resultater for vores
pilotstudie af Hjælp til Selvhjælp ud-
ført i CfA. Tidlige resultater på 20 fam-
ilier er udgivet i en brief report: *Can
Parents Treat their Anxious Child us-
ing CBT? A Brief Report of a Self-Help
Program* (Esbjørn, Christiansen, Walc-
zak, Østergaard & Breinholst, 2016).

Metode

Procedure og deltagere

Forældrene henvendte selv deres børn
til CfA med henblik på behandling i en
universitetsklinik. Vores inklusions-
kriterier til Hjælp til Selvhjælp var 1)
børnene var mellem 7-14 år gamle, 2)
børnene skulle opfylde kriterierne for
enten separationsangst, generaliseret
angst, social fobi eller specifik fobi som
deres primære lidelse, 3) deres angstli-
delse var af moderat sværhedsgrad
målt ved funktionsforstyrrelse/clinical
severity rating i ADIS-C/P (Silverman,
Albano & Barlow, 1996): 4-7 ud af 8
(en funktionsforstyrrelse rangerer mel-
lem 0-8, hvoraf 4 indikerer et klinisk
niveau), 4) barnet havde en estimeret
IQ ≥ 70 , 5) familien havde ikke tidlige-

re modtaget behandling for deres barns angstlidelse, og 6) minimum én af forældrene talte dansk.

Personalet, der varetog udredningerne før og efter behandling, var enten uddannede psykologer eller psykologistuderende trænet i udredning med Anxiety Disorder Interview Schedule Parent and Child Report (ADIS-IV-C/P, Silverman, Albano & Barlow, 1996). Personalet var blindet over for børnenes diagnostiske status, behandlingstype og progression i behandling. Personalet modtog supervision af en supervisor trænet i psykiatriske undersøgelser. Samme supervisor så alle videooptagelser af udredningerne igennem og validerede de givne eller manglende diagnoser.

Ved intake blev i alt 26 familier inkluderet. Børnenes gennemsnitsalder var 10,4 år $\pm$ 2 år, og 10 (38,5 %) af børnene var piger. De primære angstlidelser var fordelt som følger: generaliseret angst (53,8 %), separationsangst (23,1 %), specifik fobi (15,4 %) og social fobi (7,7 %) med en gennemsnitlig funktionsforstyrrelse (CSR) på 5,7 $\pm$ 0,7. Lidt over halvdelen af børnene (57,7 %) inkluderet i Hjælp til Selvhjælp havde ko-morbide angstlidelser til deres primære angstlidelse. Af de 26 inkluderede familier gennemførte 21 familier. En enkelt familie afslog behandlingen inden behandlingsstart, og fire familier droppede ud af behandlingen undervejs i programmet. Det giver en afvisningsrate på 3,8 % og en dropout rate på 15 %.

Interviews og spørgeskemaer

Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV, Child and Parent Versions

(ADIS-IV-C/P, Silverman, Albano & Barlow, 1996). Dette er et klinisk, diagnostisk interview, som måler angstsymptomer hos børn. Det består af to uafhængige interviews, der hhv. kan administreres til enten forældre eller barnet selv. Symptomerne vurderes på en skala fra 0-8, hvoraf en score ≥ 4 indikerer et klinisk angstniveau. Vi konstruerede en samscore baseret på både forældre- og barnerapport.

Revised Children's Anxiety and Depression scale (RCADS, Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto & Francis, 2000) er et spørgeskema designet til screening af angstsymptomer. Spørgeskemaet består af 47-items fordelt på fem angstskaaler (social fobi, panikangst, agorafobi, generaliseret angst, specifik fobi, obsessiv-kompulsiv lidelse) samt en depressionsskala. Symptomer rates af barn og forældre på en 4-punktskala. Højere scores indikerer en højere sværhedsgrad af symptomer. Til pilotstudiet benyttede vi en samlet angstscore baseret på en sammenlægning af de fem angstskaaler.

Resultater

Af de 26 familier, der blev inkluderet i pilotstudiet i CfA, gennemførte de 21 familier behandlingen inden for en periode af 12 uger. Der blev ikke fundet nogle statistisk signifikante eller face-value – forskelle mellem de familier, der gennemførte og afviste/droppede ud af programmet på parametrene angivet i **Tabel 1**.

Vi beregnede behandlingseffekt ved brug af Intent-to-treat (ITT) analyse. Ved ITT-analyserne blev den manglende rapport fra dropoutfamilier ved post overført fra intake-undersøgelsen. Det-

Barnet	Forældre
Alder	Husstandsindkomst
Køn	Ægteskabelig status
IQ	Uddannelsesniveau
Grad af symptomer	Psykiske lidelser
CSR-vurdering / Funktionsforstyrrelse af diagnose	Forældrerapport af CSR-vurdering af barns diagnose
Antallet af diagnoser	Forældrerapport af antallet af diagnoser hos barn

Tabel 1. Oversigt over undersøgte forskelle i barne- og forældreparametre mellem familier, der gennemførte og afviste/droppede ud af Hjælp til Selvhjælp.

Note: Forældrerapport af egen psykiske lidelser baserer sig på angst- og depressionssymptomer målt ved DASS-21; CSR-vurdering og antal af diagnoser baserer sig på ADIS-C/P.

te kaldes *last observation carried forward* metoden, og er den mest konservative metode til at evaluere behandlingseffekt. Det vil derfor antages, at der ingen effekt har været for disse familier. Et positivt behandlingsresultat blev defineret som, at barnet ikke opfyldte diagnostiske kriterier for en angstlidelse efter behandlingens afslutning. ITT-analyser viste, at 61,5 % af alle børnene inkluderet i pilotstudiet blev fri for alle deres angstlidelser efter endt behandling. Samme procentdel er gældende, når vi ser på, om børnene blot bliver fri for deres primære angstlidelse. Vi udførte desuden parrede t-tests for at sammenligne børnenes egne rapporterede angstsymptomer samt forældrenes rapport af barnets angstsymptomer før og efter behandling. Her indikerer ITT-analyserne et signifikant fald i den gennemsnitlige score på RCADS total angstsкала før ($M=33.5$, $SD=15.0$) og efter ($M=20.6$, $SD=12.9$); $p < 0.001$. Der blev også fundet en signifikant forskel i forældrenes rapport af deres barns angst-

symptomer med den gennemsnitlige RCADS-score før ($M=35.7$, $SD=13.1$) og efter ($M=21.5$, $SD=14.5$) behandling; $p < 0.001$ for mødrenes rapport, og den gennemsnitlige RCADS-score før ($M=31.8$, $SD=12.3$) og efter ($M=23.7$, $SD=13.3$) behandling; $p=0.001$ for fædrenes rapport.

Videre er der udregnet effektstørrelserne for børnenes og forældrenes score på RCADS total angstsкала før og efter behandling. Effektstørrelser er et statistisk outcome-mål, der indikerer hvor stor ændringen har været før til efter behandling. En effektstørrelse fortolkes klassisk som følgende; en effektstørrelse mellem 0.01-0.20 klassificeres som lille, hvor 0.50 angiver en medium effektstørrelse, og endeligt angiver alt over 0.80 en stor effektstørrelse (Cohen, 1988). Ved intent-to-treat analyser af børnenes selvrappport og forældrenes rapport af barnets angstsymptomer blev der fundet store effektstørrelser; med børnenes selvrappport før og efter behandling (intent-to-treat Cohen's $d=0.962$), mødres rapport

af barnets symptomatologi (intent-to-treat Cohen's $d=1.083$) og fædrenes rapport af barnets symptomatologi pre-til postbehandling (intent-to-treat Cohen's $d=0.825$).

Diskussion af resultater i pilotstudiet

Pilotstudiet i CfA havde til formål at undersøge behandlingseffekten af et forældrebaseret selvhjælpsprogram med minimal terapeutkontakt til børn med moderate niveauer af angst. Vi forventede, at Hjælp til Selvhjælp ville vise sig at være effektivt, om end kun med en medium effektstørrelse som tidligere forskning i selvhjælpsprogrammer med samme niveauer af terapeutkontakt har vist sig at være. De udførte ITT-analyser viste, at 61,5 % af alle børnene inkluderet i studiet blev fri for alle deres angstlidelser efter 12 ugers Hjælp til Selvhjælp. Dette er et mere positivt resultat end forventet, idet det svarer til den forbedring, der ses ved terapeutleverede kognitivt adfærdsterapeutiske programmer, hvor 58,9 % af alle børn bliver fri for alle deres angstlidelser (James, James, Cowdrey, Soler & Choke, 2015). Effekten af Hjælp til Selvhjælp svarer endvidere til den bedring, der viste sig når forældre modtog 9 ugentlige telefonopkald fra en terapeut i det australske selvhjælpsstudie; 79 % af børnene var fri for alle deres angstlidelser (Lyneham & Rapee, 2006). Det bør dog bæres i mente, at Hjælp til Selvhjælp opnår samme positive effekt med et væsentligt mindre antal brugte terapeuttimer pr barn, idet terapeuten bruger 1,25 time pr familie i Hjælp til Selvhjælp sammenlignet med de 9 timer

pr. familie, der skal kontaktes telefonisk i det australske selvhjælpsprogram. Dette resultat er endvidere positivt, når der sammenlignes med et andet dansk studie: Arendt og kollegaer (2016) undersøger effekten af terapeutleveret Cool Kids og finder, at 48,2 % af børnene bliver fri for alle deres angstlidelser. Pilotstudiets effekt af Hjælp til Selvhjælp er derfor i face-value højere end den, der er fundet ved standard terapeutleveret Cool Kids i Danmark. Dog når vi ser på Arendt og kollegaers (2016) rapporterede effektstørrelser før og efter behandling baseret på ADIS samlede CSR-score og Spence Children's Anxiety Scale (mother, father og child report) kan disse alle karakteriseres som store. I vores pilotstudie har vi ikke inkluderet effektstørrelser af ADIS samlede CSR-score eller benyttet Spence Children's Anxiety Scale, hvilket besværliggør en direkte sammenligning af de to studiers effektstørrelser. En anden væsentlig forskel mellem studierne er hvilke børn, der modtog behandling. Arendt og kollegaer (2016) inkluderede alle børn med en primær angstlidelse diagnosticeret med ADIS-C/P uanset sværhedsgrad (CSR: 4-8), hvor nærværende pilotstudie kun inkluderede de børn, der blev vurderet til at have moderate niveauer af angst (CSR:4-7). Denne opmærksomhed er videre relevant, når der sammenlignes med effekterne af en anden høj-intensiv behandling, der foregår via forældrene; Timid to Tiger programmet (Cartwright-Hatton et al., 2011). Her var 32 % af børnene fri for alle deres angstlidelser, hvilket er en del lavere end effekten

fundet ved Hjælp til Selvhjælp. CfA's eksklusion af børn med svære angsttilstande samt det lille sample på 26 børn kan derfor forklare, hvorfor Hjælp til Selvhjælp programmet umiddelbart lader til at have bedre effekt end disse to høj-intensive behandlingsprogrammer. Selvom det ikke influerer på behandlingseffektens tal, bør man ligeledes huske på den høje dropout rate i Hjælp til Selvhjælp (15 %), der overstiger den almindelige dropout rate ved høj-intensiv traditionel CBT-behandling. Dette tyder på, at Hjælp til Selvhjælp kan have stor effekt for nogle, men at programmet ikke er for alle.

Vores udgangspunkt var som nævnt at teste et ressourcebesparende, lav-intensivt behandlingsprogram, der let ville kunne implementeres i en hverdagssetting, eksempelvis i en kommune. Med et sådan behandlingsprogram ville det være muligt at opspore og behandle angst hos langt flere børn tidligt og dermed forhindre alvorlige, kliniske niveauer senere i barnets udvikling. Dermed ville man potentielt også kunne reducere de generelle samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med at behandle svær psykopatologi (Bodden, Dirksen & Bögers, 2008). Nærværende pilotstudie tyder på, at Hjælp til Selvhjælp kan være mere effektivt end de eksisterende, internationale selvhjælpsprogrammer med minimal terapeutisk kontakt. Resultaterne af pilotprojektet indikerer derfor samlet, at Hjælp til Selvhjælp, selvom terapeuterne gennemsnitligt kun benytter 1,25 time pr familie, kan være en lovende lav-intensiv, forebyggende intervention til børn med moderat angst.

Fra pilotprojekt i en specialiseret behandlingsklinik til implementering i en dansk kommune

Som følge af ovenstående pilotprojekt modtog CfA en bevilling fra VELUX Fonden til at implementere Hjælp til Selvhjælp i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi implementerede programmet i efteråret 2016, og projektet forventes afsluttet i begyndelsen af 2019. Det primære formålet er at nedbringe antallet af angstbørn i kommunen på længere sigt ved at tilbyde et forebyggende selvhjælpsprogram til forældre, hvis børn er angstelige eller lider af moderat angst. Personale i CfA har trænet en udvalgt gruppe af PPR personale fra Lyngby-Taarbæk i at forestå workshops og dermed Hjælp til Selvhjælp. Det sekundære formål med denne implementering er også at undersøge effekten af Hjælp til Selvhjælp i hverdagens praksis uden for en specialiseret behandlingsklinik. For at sikre bedst mulig og gnidningsfri implementering, har CfA udviklet et træningsprogram tilrettelagt specifikt til PPR personale med formålet at ruste dem til selvstændigt at varetage Hjælp til Selvhjælp. Som tidligere nævnt kræver det grundigt træning og supervision at kunne forestå en CBT-behandling selvsikkert og uden åbenlys tvivl. Træningsprogrammet fokuserer på en indføring i CBT principper og teknikker, uddannelse i viden om angst hos børn samt beslægtede problematikker samt løbende supervision for alle de forskellige gruppeforløb. Supervisionen tager udgangspunkt i videooptagelser af de pågældende work-

shops, idet behandlere herigennem kan få konstruktiv feedback og justere, hvis de er kommet ud af kurs i forhold til programmet. Brugen af videosupervision giver behandlerne den mest optimale mulighed for at få feedback på både egen stil og deres formidling af principper, teknikker samt psykoedukation til forældre.

Hvis de lovende resultater fra CfA's pilotprojekt af Hjælp til Selvhjælp gentages ude i kommunen, vil CfA arbejde på at implementere programmet i andre kommuner i Danmark og dermed tilbyde tilsvarende træning til øvrige kommuners PPR i det omfang, der er interesse herfor. Nærværende artikel har hermed rapporteret vores foreløbige resultater fra Hjælp til Selvhjælp. CfA har et ønske om, at dette program kan være et vigtigt skridt i målet om at mindske antallet af angstbørn i Danmark. Kun gennem mere forskning i dette program samt tilhørende justering af dette, kan de ressourcebesparende behandlinger, der tilsvarende kommunernes ressourceniveau, effektiveres og dermed give liv til idéen om, at flere og flere børn kan leve et liv fri af angsten.

Referencer

- Arendt, K., Thastum, M. & Hougaard, E. (2015): Efficacy of a Danish version of the Cool Kids program: a randomized wait-list controlled trial. *Acta Psychiatrica Scandinavica* 2015, pp. 1-13.
- Bodden, D. H., Dirksen, C. D., & Bögels, S. M. (2008). Societal burden of clinically anxious youth referred for treatment: a cost-of-illness study. *Journal of abnormal child psychology*, 36(4), 487-497.
- Cartwright-Hatton, S., McNally, D., Field, A. P., Rust, S., Laskey, B., Dixon, C., ... & Symes, W. (2011). A new parenting-based group intervention for young anxious children: Results of a randomized controlled trial. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 50(3), 242-251.
- Chorpita, B. F., Yim, L., Moffitt, C., Umemoto, L. A., & Francis, S. E. (2000). Assessment of symptoms of DSM-IV anxiety and depression in children: A revised child anxiety and depression scale. *Behaviour research and therapy*, 38(8), 835-855.
- Christiansen, B. M. & Esbjørn, B. H. (unpublished manuscript). *Hjælp til Selvhjælp – Cool Kids program*.
- Creswell, C., Violato, M., Fairbanks, H., White, E., Parkinson, M., Abitabile, G., ... & Cooper, P. (2017). A randomised controlled trial of Brief Guided Parent-delivered Cognitive Behaviour Therapy and Solution Focused Brief Therapy for the treatment of child anxiety disorders: clinical outcome and cost-effectiveness. *The Lancet Psychiatry*.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. Routledge.

- Copeland, W. E., Angold, A., Shanahan, L., & Costello, E. J. (2014). Longitudinal patterns of anxiety from childhood to adulthood: the Great Smoky Mountains Study. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 53(1), 21-33.
- Esbjørn, B. H., Christiansen, B. M., Walczak, M., Østergaard, S. W. & Breinholt, S. (2016). Can parents treat their anxious child using CBT? A brief report of a Self-help program. *Acta Psychopathologica*.
- Ischikawa, S., Okajima, I., Matsuoka, H. & Sakano, Y. (2007): Cognitive Behavioural Therapy for Anxiety Disorders in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. *Child and Adolescent Mental Health*, 12, pp. 164-172.
- James, A. C., James, G., Cowdrey, F. A., Soler, A., & Choke, A. (2015). Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents. *the cochrane library*.
- Lebowitz, E. R., Omer, H., Hermes, H., & Scahill, L. (2014). Parent training for childhood anxiety disorders: the SPACE program. *Cognitive and Behavioral Practice*, 21(4), 456-469.
- Lyneham, H. J., & Rapee, R. M. (2006). Evaluation of therapist-supported parent-implemented CBT for anxiety disorders in rural children. *Behaviour Research and Therapy*, 44, pp. 1287-1300.
- Manassis, K., Lee, T. C., Bennett, K., Zhao, X. Y., Mendlowitz, S., Duda, S., Saini, M., Wilansky, P., Baer, S., Barret, P., Bodden, D., Cobham, V. E., Dadds, M. R., Flannery-Schroeder, E., Ginsburg, G., Heyne, D., Hudson, J. L., Kendall, P. C., Liber, J., Masia-Warner, C., Nauta, M. H., Rapee, R. M., Silverman, W., & Siqueland, L. (2014). Types of parental involvement in CBT with anxious youth: A Preliminary Meta-Analysis. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 82, pp. 1-10.
- Moffitt, T. E., Harrington, H., Caspi, A., Kim-Cohen, J., Goldberg, D., Gregory, A. M., & Poulton, R. (2007). Depression and generalized anxiety disorder: cumulative and sequential comorbidity in a birth cohort followed prospectively to age 32 years. *Archives of general psychiatry*, 64(6), 651-660.
- Rapee, R. M., Lyneham, H. J., Schniering, C. A., Wuthrich, V., Abbott, M. A., Hudson, J. L., & Wignall, A. (2006). *Cool Kids: Child & Adolescent Anxiety Program*. Centre for Emotional Health.
- Reijntjes, A., Kamphuis, J. H., Prinzie, P., & Telch, M. J. (2010). Peer victimization and internalizing problems in children: A meta-analysis of longitudinal studies. *Child abuse & neglect*, 34(4), 244-252.
- Silverman, W. K., Albano, A. M., & Barlow, D. H. (1996). *Manual for the ADIS-IV-C/P*. New York, NY: Psychological Corporation.
- Sundhedsstyrelsen (8. September 2015): <http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-rapport-sygdomsbyrden-i-danmark#>
- Spence, S. H., Donovan, C. L., March, S., Gamble, A., Anderson, R. E., Prosser, S., & Kenardy, J. (2011): A randomized controlled trial of online versus clinic-based CBT for adolescents anxiety. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 29, pp. 629-642.